

## C

急性・亜急性間質性肺炎  
acute/subacute interstitial pneumonias

## 1

## 特発性器質化肺炎

cryptogenic organizing pneumonia (COP)

## 到達目標

- 器質化肺炎（OP）の概念を説明できる
- COP の症候と身体所見を説明できる
- COP の胸部画像や気管支肺泡洗浄液所見の特徴を説明できる
- COP の診断プロセスを説明できる
- COP の治療と予後を説明できる

## 病因・病態・疫学

器質化肺炎（organizing pneumonia：OP）は、肺傷害の際に生じる病理学的パターンのひとつであり、表 1 に示すようなさまざまな疾患や病態で観察される非特異的な所見である。終末～呼吸細気管支、肺胞道、肺胞腔内にかけて器質化病変がみられ、同部位の間質には炎症細胞の浸潤が認められる（図 1）。細気管支病変が注目され bronchiolitis obliterans organizing pneumonia（BOOP）とも呼ばれたが、病変の主体が肺胞道から肺胞領域であるため、最近では OP と呼称される<sup>1)</sup>。

特発性器質化肺炎（cryptogenic OP：COP）は原因不明であり、亜急性の発症様式、典型的な胸部画像所見および良好なステロイド反応性などから、独立した臨床病理学的疾患概念とされる。胞隔炎が存在することや臨床的に他の間質性肺炎と区別しにくいことがあり、特発性間質性肺炎に分類される<sup>2,3)</sup>。

COP 発症の平均年齢は 50 歳代で、男女差はなく、喫煙のリスクは否定的である<sup>4)</sup>。

## 症候・身体所見

発症は急性または亜急性であり、咳、息切れ、発熱、倦怠感、体重減少などがみられる。経過中に下気道感染として対応されることも多い。胸部聴診では捻

髪音を聴取することがあるが、パチ指は認めない<sup>4)</sup>。

## 診断・検査

診断には、肺における OP 所見の確認が必要である。OP 所見は表 1 に示すような他疾患の minor component として観察されることもある。典型的な臨床症状や胸部画像所見があり、経気管支肺生検（transbronchial lung biopsy：TBLB）にて OP 所見が観察されれば COP と診断可能である<sup>1)</sup>。一方、TBLB 組織像や画像所見が非典型的な場合、副腎皮質ステロイド薬への反応性が不良な場合には外科的肺生検を考慮する必要がある。

最終的に COP と診断するには表 1 に示すようなさまざまな病態を除外することが必要である。各種自己抗体の血清学的検査を行い、膠原病に伴う OP を除外する。血液検査では軽度の白血球増多や CRP の上昇があり、呼吸機能検査では軽～中等度の拘束性障害が認められる。低酸素血症は軽度であることが多い。

胸部画像所見は、典型的には両側、多発性 consolidation が胸膜直下や気管支血管束に沿った分布を示し、しばしば、気管支透亮像、すりガラス陰影を伴い、陰影は移動性を示す（図 2a, b）。まれに、片側性陰影、結節性陰影、空洞を呈し、胸水を伴う。細菌性肺炎との区別が困難な場合があり、抗菌薬投与無効から COP の可能性が考慮される。すりガラス陰影が目立つケースでは非特異性間質性肺炎（NSIP）などの他の間質性肺炎との鑑別も問題となる。特徴的な CT 所見として、perilobular sign や reversed halo sign（図 2c）が報告されている。

気管支肺泡洗浄液の細胞分画ではリンパ球分画が上昇し（20～40%）、CD4/CD8 は低下する<sup>4)</sup>。

表 1 COP の主な鑑別診断

1. IIP の他の病型；cellular NSIP, AIP/DAD
2. 細菌感染による肺炎
3. 膠原病に伴う間質性肺疾患
4. 好酸球性肺炎
5. 薬剤性肺炎
6. 放射線肺炎
7. 多発性血管炎肉芽腫症（granulomatosis with polyangiitis）
8. 閉塞性細気管支炎
9. 過敏性肺炎
10. その他の非特異的な器質化病変；腫瘍の周囲など

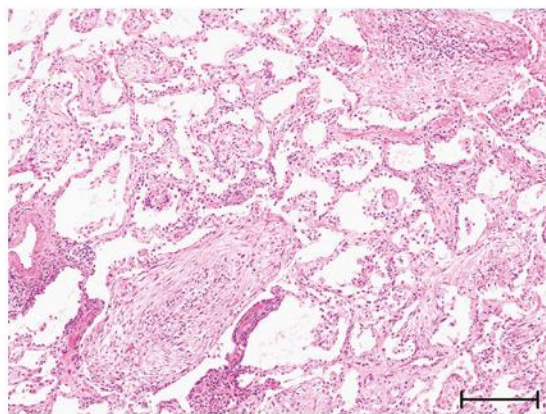


図 1 器質化肺炎の病理所見（スケールは 100 μm）